GUÍA PARA FAMILIAS · ALERGIA ALIMENTARIA

Qué hacer en caso de alergia alimentaria

reconocer los síntomas y actuar a tiempo

Una reacción alérgica a un alimento suele empezar en minutos, y casi siempre en las dos horas siguientes a comerlo. La mayoría son leves, pero algunas se complican deprisa. **Reconocerlas y tener un plan** marca la diferencia.

1 Cómo se manifiesta

En la piel

- Ronchas que pican (urticaria)
- Enrojecimiento
- Hinchazón de labios, párpados o cara

Boca y tripa

- Picor de boca o garganta
- Vómitos
- Dolor de tripa o diarrea

Respiración

- Estornudos y mocos
- Tos, ronquera o pitos
- Dificultad para respirar

Estado general

- Palidez y sudor frío
- Mareo o flojera
- Desmayo

En bebés puede verse solo como llanto inconsolable, vómitos, flojera o mucho sueño de repente. Y no siempre hay ronchas: **una reacción grave puede no tener ningún síntoma en la piel**.

2 Señales de alarma

Qué es una anafilaxia

Es la reacción alérgica más grave: aparece rápido, afecta a varias partes del cuerpo a la vez y puede poner en peligro la vida. Es una urgencia.

Le cuesta respirar
pitos, tos que no para o se ahoga

Garganta
voz ronca, le cuesta tragar o babea

Hinchazón
de lengua, labios o garganta

Mareo o desmayo
palidez, flojera, está muy apagado

Vómitos repetidos
con dolor de tripa intenso

Empeora rápido
los síntomas se suman en minutos

Cualquiera de estas señales, o síntomas en dos o más partes del cuerpo a la vez, es una anafilaxia hasta que se demuestre lo contrario.

3 Qué hacer, paso a paso

REACCIÓN LEVE **solo piel o picor de boca**

Retira el alimento sin provocar el vómito y dale el **antihistamínico** que indique su plan.

No le quites ojo durante al menos dos horas. Si aparece cualquier señal de alarma, actúa como en una anafilaxia.

ANAFILAXIA **sin esperar**

1 **Adrenalina en el muslo**
Con el autoinyector, en la **cara externa del muslo**. Se puede poner encima de la ropa.

2 **Llama al 112**
Di la palabra **«anafilaxia»** y que ya le has puesto adrenalina.

3 **Túmbalo y no lo levantes**
Con las piernas en alto. Si le cuesta respirar, sentado; si vomita o está inconsciente, de lado. **Que no se ponga de pie** ni camine.

4 **Segunda dosis si no mejora**
Si a los 5 a 15 minutos sigue igual o peor, pon el segundo autoinyector.

5 **Siempre a urgencias**
Aunque mejore: los síntomas pueden **volver horas después** y necesita vigilancia.

La adrenalina es lo primero. El antihistamínico o el inhalador pueden darse después, pero nunca la sustituyen. Ponerla cuando no hacía falta casi nunca es un problema; retrasarla sí lo es.

4 Prevenir en casa y en el cole

✓ **Leer la etiqueta, siempre**
Cada vez, aunque sea el producto de siempre: las recetas cambian. Evita también lo que diga «puede contener trazas».

✓ **Dos autoinyectores, a mano**
Que vayan con él a todas partes y estén en vigor. Revisa la fecha y que el líquido sea transparente.

✓ **Un plan escrito para el colegio**
Con su foto, sus alergias y qué hacer. Que el profesorado y el comedor sepan usar el autoinyector.

✓ **Cuidado con los utensilios**
Tablas, cuchillos, aceite de freír o la plancha del bar pueden pasar el alérgeno a otro alimento.

✓ **Que aprenda a cuidarse**
A decir que es alérgico, a no aceptar comida sin preguntar y a pedir ayuda si nota algo raro.

Habla con tu pediatra si

- Ha tenido una reacción, aunque fuera leve: hay que estudiarla.
- Quieres quitar o volver a dar un alimento: **sin diagnóstico no se retira**, y la reintroducción se planifica.
- Necesitas repasar su plan de acción o cómo usar el autoinyector.
- Ha crecido: la dosis de adrenalina depende del peso.

Ante la duda,
adrenalina y 112.

emmapediatra.com
Dra. Emma López Rubio
Pediatría y Gastroenterología Infantil · Córdoba

No sustituye la consulta ni el plan de acción de tu hijo.
© 2026 Dra. Emma López Rubio. Todos los derechos reservados.